

LAPORAN SUPERVISI DENGAN OBSERVASI RSPH Malang

NO	TANGGAL	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPANTAU/ OBSERVASI	HASIL TEMUAN	RTL	Keterangan
1.	Periode 5/12/2024- 7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Waktu tunggu hasil pembacaan CXR di IGD terlalu lama sehingga menghambat pelayanan, terutama menentukan pasien dengan kondisi pneumonia/Tb paru	-sosialisasi DPJP terkait waktu tunggu bacaan radiologi di IGD (semua hasil bacaan foto baik CXR maupun foto yang lain) → saran untuk ditentukan maksimal waktu tunggu hasil pembacaan foto terutama di IGD -saran untuk membuat grup WA antara dokter jaga IGD dan spesialis radiologi sehingga waktu tunggu pembacaan foto sementara dapat dipangkas.	- diperlukan evaluasi setelah 1 bulan pelaksanaan sosialisasi melibatkan DPJP radiologi, dokter umum IGD dan pihak terkait

					-penyediaan DS radiologi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan serta ketepatan layanan. -saran untuk waktu tunggu hasil foto bisa <2 jam	
2.	Periode 5/12/2024-7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Waktu tunggu balasan DPJP di IGD (via wa) paling cepat adalah 10 menit – paling lama >8 jam (beberapa DPJP seperti paru dan neuro)	-adanya waktu maksimal untuk menghubungi DPJP atau diperlukan adanya sosialisasi kembali management terkait respon time menjawab terutama pada kasus <i>emergency / cito</i> sehingga pelayanan pasien tidak tertunda -saran adanya kesepakatan DPJP dan management	-diperlukan monitoring / evaluasi selama 2 minggu-1 bulan secara berkala untuk dilaporkan pada Penanggung jawab IGD dan management RS

					terkait batas maksimal menjawab terutama pada kasus <i>emergency</i>	
3.	Periode 5/12/2024-7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Kondisi over capacity dari IGD dengan total saat ini 20 bed pasien dan 2 bed ponek. Saat ini rencana pengajuan tambahan 2 bed	-adanya SOP yang jelas terkait kondisi over load yang terjadi yang tidak terjadi di setiap shift karena terkadang meminjam di IKO sebagai antisipasi apabila sedang ada tindakan operasi maka bed akan kurang -saran bisa ditambahkan 1 atau 2 bed cadangan yang bisa digunakan ketika kondisi overload pasien dengan SOP yang jelas.	-
4.	Periode 5/12/2024-7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Saat pindah ruangan biasanya harus	-adanya komunikasi 2 arah antara	-monitoring selama 1

				menunggu telf konfirmasi dari IGD untuk pindah.	perawat ruangan dan perawat IGD sehingga waktu tunggu bisa dipangkas. -hal ini juga meningkatkan kekompakan antar perawat ruangan dan IGD sehingga tercipta suasana yang harmonis antara masing masing unit	bulan terkait perpindahan pasien/ transfer pasien
5.	Periode 5/12/2024-7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Proses KIE untuk naik op yang sudah acc namun tidak ada persetujuan secara tertulis di f9 (lembar KIE) maupun f5 (lembar persetujuan tindakan)	-ketika proses KIE pasien seharusnya dapat dibuat lebih detail dan bukti KIE harus ada di lembar persetujuan maupun lembar KIE hal ini apabila memang dioperkan maka harus dipastikan bahwa lembar tersebut sudah diisi. Hal ini merupakan perkara teknis namun memiliki dampak hukum yang sangat	

					berat implikasinya sehingga adanya penyeragaman terkait pengisian form.	
6.	Periode 5/12/2024-7/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Pasien dengan demam 7 hari sesuai syarat BPJS harus diatas 39,4 C. Hal ini pasien dengan DL dan IGM Salmonella harus dicekkan umum baru apabila MRS dapat diklaim.	-beberapa saran antara lain komunikasi dan penyeragaman terkait info hal ini penting untuk dilakukan antara DPJP dan Dr IGD -pola komunikasi harus diperbaiki dengan lebih meng KIE terkait kapan kondisi harus kembali ke RS sehingga pasien tahu kapan harus kembali apabila ada perburukan kondisi.	
7.	Periode 30-31/12/2024	Observasi IGD	Unit IGD	Pasien dengan usia tua, GEA, secara klinis sudah ada tanda dehidrasi (turgor melambat, takikardia). Tapi Lab SE normal. DPJP IPD tidak ada yang mau menerima pasien dengan alasan takut tidak terklaim. Akhirnya pasien dipulangkan.	-Saran saat diagnosis di IGD masih belum jelas apakah rawat inap atau rawat jalan maka dapat diberikan tatalaksana awal. -dapat di KIE untuk segera kembali ke IGD maka komunikasi harus baik	Evaluasi kunjungan IGD 2-4 minggu.

					-bila pasien tetap ingin di MRS maka dapat ditawarkan untuk menjadi pasien umum.	
--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui
Direktur PT. Disa Prima Medika

Supervisor

dr. Sefrina Trisadi

dr. Adhya Aji Pratama



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

SUPERVISI MANAGEMENT IGD

**PT DISA PRIMA MEDIKA | RS PRIMA HUSADA
MALANG**

DESEMBER 2024

PERIODE 5-7 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
Waktu tunggu hasil pembacaan CXR di IGD terlalu lama	-sosialisasi DPJP terkait waktu tunggu bacaan radiologi di IGD (semua hasil bacaan foto baik CXR maupun foto yang lain) → saran untuk ditentukan maksimal waktu tunggu hasil pembacaan foto terutama di IGD -saran untuk membuat grup WA antara dokter jaga IGD dan spesialis radiologi -penyediaan DS radiologi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan serta ketepatan layanan. -saran untuk waktu tunggu hasil foto bisa <2 jam	- diperlukan evaluasi setelah 1 bulan pelaksanaan sosialisasi melibatkan DPJP radiologi, dokter umum IGD dan pihak terkait
Waktu tunggu balasan DPJP di IGD (via wa) paling cepat adalah 10 menit – paling lama >8 jam	-adanya waktu maksimal untuk menghubungi DPJP atau diperlukan adanya sosialisasi kembali management terkait respon time menjawab terutama pada kasus <i>emergency</i> / <i>cito</i> sehingga pelayanan pasien tidak tertunda -saran adanya kesepakatan DPJP dan management terkait batas maksimal menjawab terutama pada kasus <i>emergency</i>	-diperlukan monitoring / evaluasi selama 2 minggu-1 bulan secara berkala untuk dilaporkan pada Penanggung jawab IGD dan management RS

PERIODE 5-7 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
Kondisi over capacity dari IGD dengan total saat ini 20 bed pasien dan 2 bed ponek. Saat ini rencana pengajuan tambahan 2 bed	-adanya SOP yang jelas terkait kondisi over load yang terjadi yang tidak terjadi di setiap shift karena terkadang meminjam di IKO sebagai antisipasi apabila sedang ada tindakan operasi maka bed akan kurang -saran bisa ditambahkan 1 atau 2 bed cadangan yang bisa digunakan ketika kondisi overload pasien dengan SOP yang jelas.	-
Saat pindah ruangan biasanya harus menunggu telf konfirmasi dari IGD untuk pindah.	-adanya komunikasi 2 arah antara perawat ruangan dan perawat IGD sehingga waktu tunggu bisa dipangkas. -hal ini juga meningkatkan kekompakan antar perawat ruangan dan IGD sehingga tercipta suasana yang harmonis antara masing masing unit	-monitoring selama 1 bulan terkait perpindahan pasien/ transfer pasien

PERIODE 5-7 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
Proses KIE untuk naik op yang sudah acc namun tidak ada persetujuan secara tertulis di f9 (lembar KIE) maupun f5 (lembar persetujuan tindakan)	-ketika proses KIE pasien seharusnya dapat dibuat lebih detail dan bukti KIE harus ada di lembar persetujuan maupun lembar KIE hal ini apabila memang dioperkan maka harus dipastikan bahwa lembar tersebut sudah diisi. Hal ini merupakan perkara teknis namun memiliki dampak hukum yang sangat berat implikasinya sehingga adanya penyeragaman terkait pengisian form.	monitoring selama 1 bulan terkait proses KIE pasien
Pasien dengan demam 7 hari sesuai syarat BPJS harus diatas 39,4 C. Hal ini pasien dengan DL dan IGM Salmonella harus dicekkan umum baru apabila MRS dapat diklaim.	-beberapa saran antara lain komunikasi dan penyeragaman terkait info hal ini penting untuk dilakukan antara DPJP dan Dr IGD -pola komunikasi harus diperbaiki dengan lebih meng KIE terkait kapan kondisi harus kembali ke RS sehingga pasien tahu kapan harus kembali apabila ada perburukan kondisi.	

PERIODE 30–31 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
Pasien dengan usia tua, GEA, secara klinis sudah ada tanda dehidrasi (turgor melambat, takikardia). Tapi Lab SE normal. DPJP IPD tidak ada yang mau menerima pasien dengan alasan takut tidak terklaim. Akhirnya pasien dipulangkan.	-Saran saat diagnosis di IGD masih belum jelas apakah rawat inap atau rawat jalan maka dapat diberikan tatalaksana awal. -dapat di KIE untuk segera kembali ke IGD maka komunikasi harus baik -bila pasien tetap ingin di MRS maka dapat ditawarkan untuk menjadi pasien umum.	Evaluasi kunjungan IGD 2-4 minggu.